

Terapia Renal Substitutiva

Vamos conversar sobre um tema que aparece com frequência nas provas de residência e que, na prática clínica, faz parte do dia a dia de quem acompanha pacientes com doença renal crônica avançada: a **terapia renal substitutiva (TRS)**. A ideia aqui é entender quando indicar, quais são as modalidades disponíveis e quais conceitos as bancas mais gostam de cobrar.

Primeiramente, um ponto que é absolutamente central e que você precisa gravar: **não existe uma taxa de filtração glomerular (TFG) que, isoladamente, defina o início da diálise**. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Se a questão afirmar algo como "todo paciente com TFG menor que 15 mL/min deve iniciar diálise", desconfie imediatamente — está incorreto. A decisão de dializar é individualizada e leva em conta o quadro clínico global do paciente. O que a gente observa na prática é que a maioria dos pacientes acaba iniciando diálise com **TFG abaixo de 10 mL/min**, mas isso é uma tendência, não uma regra fixa.

Então, o que de fato pesa na decisão? Você vai olhar para o paciente como um todo. Pergunte-se: esse paciente já teve **todo o tratamento conservador otimizado** e, mesmo assim, continua deteriorando? Ele apresenta sinais e sintomas que não respondem mais ao manejo clínico? Além disso, é fundamental avaliar o **nível cognitivo e o suporte familiar** do paciente, porque a TRS exige compreensão e adesão ao tratamento.

Agora, vamos às modalidades propriamente ditas. Aqui entra outro conceito-chave para a prova: **não há superioridade comprovada entre hemodiálise e diálise peritoneal**. Cada método tem suas particularidades, vantagens e limitações, e a escolha depende do perfil do paciente, da estrutura disponível e das preferências individuais.

A **hemodiálise (HD)** utiliza uma **membrana semipermeável artificial** — o famoso capilar, aquele dispositivo com milhares de fibras finas por onde o sangue do

paciente circula. O princípio físico envolvido é a **difusão**: as substâncias se movem do meio mais concentrado para o menos concentrado. Na prática, funciona assim: se o objetivo é remover potássio do paciente, o banho de diálise (dialisato) é preparado com uma concentração baixa de potássio, de modo que o potássio do sangue migre para o dialisato pelo gradiente de concentração.

Para realizar a hemodiálise, o paciente precisa obrigatoriamente de um **acesso vascular**. E aqui existe, sim, uma hierarquia de preferência. A primeira escolha é a **fístula arteriovenosa (FAV)**, que consiste em uma anastomose cirúrgica entre uma artéria e uma veia, geralmente no membro superior. A FAV é o acesso mais duradouro, com menor taxa de infecção e melhores desfechos a longo prazo. Na prática, nem sempre é possível confeccionar a FAV em tempo hábil — ela precisa de semanas a meses para maturar —, mas para a prova, num cenário ideal, a resposta será sempre a FAV como primeira opção. Em segundo lugar, temos o **cateter tunelizado de longa permanência** (como o Permcath), que é uma alternativa para pacientes que não têm FAV funcionante. E em terceiro lugar vem o **cateter não tunelizado de curta permanência**, conhecido como **Shilley**, que deve ser utilizado idealmente por **menos de duas semanas**. Na prática clínica, infelizmente, muitos pacientes acabam recebendo alta hospitalar ainda com Shilley, mas entenda que isso não é o recomendado. Para a prova, marque que o paciente **não deve ir para casa com cateter de curta permanência**.

Por outro lado, temos a **diálise peritoneal (DP)**, que utiliza o próprio **peritônio do paciente como membrana semipermeável natural**. É uma modalidade domiciliar, o que confere mais autonomia ao paciente, e é especialmente interessante para aqueles que moram longe de centros de diálise ou que valorizam a flexibilidade no tratamento. Um dado importante para as provas: estudos mostram que **pacientes que recebem informação adequada e educação em saúde sobre as modalidades de TRS tendem a preferir formas domiciliares de diálise**, como a peritoneal. Isso reforça a importância da orientação pré-dialítica e do papel do médico como educador.

Para fechar o panorama da TRS, precisamos falar sobre o **transplante renal**, que é considerado o tratamento de escolha para a doença renal crônica terminal. Entre as vantagens comprovadas estão a **menor mortalidade a longo prazo**, a **melhora significativa na qualidade de vida** e a **redução do risco cardiovascular**. Um conceito diferenciador e que pode aparecer em provas: diferentemente de outros órgãos sólidos, a alocação do rim para transplante não se baseia prioritariamente na **gravidade** do receptor, mas sim na **compatibilidade imunológica**. Após o transplante, o paciente necessita de **terapia imunossupressora de manutenção**, e classicamente essa terapia é feita com os seguintes medicamentos: **prednisona, micofenolato e tacrolimus**.

Para consolidar o que foi discutido, vale fixar os gatilhos principais deste tema. Primeiro: **não há TFG que defina o início da diálise** — a indicação é clínica e individualizada. Segundo: **não há superioridade entre hemodiálise e diálise peritoneal** — cada uma tem seu espaço. Terceiro: na hemodiálise, o acesso vascular de escolha é a **fístula arteriovenosa (FAV)**. E quarto: no transplante renal, a imunossupressão clássica é feita com **prednisona, micofenolato e tacrolimus**. Com esses pilares bem fixados, você resolve a grande maioria das questões sobre TRS nas provas de residência.